

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT ASURANSI BRI LIFE
DENGAN
PT DISA PRIMA PRIMA
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DAN OBAT
BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN PT ASURANSI BRI LIFE

Nomor: B. /PMO/PHC/IV/2024
Nomor:

Perjanjian Kerja sama antara PT Asuransi BRI Life dengan PT/YAYASAN/RS _____ tentang Pelayanan Kesehatan dan Obat Bagi Peserta Asuransi Kesehatan PT Asuransi BRI Life (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian**”) dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ (/ /) oleh dan antara:

1. **Anna Novy Handayani** jabatan **Project Manager Healthcare**, berdasarkan Akta Pendirian No: 116 tanggal 28 Oktober 1987, Akta Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Kehakiman RI No: C2-6645.HT.01.01-TH.88 tanggal 2 Agustus 1988, dimuat dalam Berita Negara RI No: 71 tanggal 04 September 1990, Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, Akta No: 8 tanggal 2 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-AH.01.03.0033868 tanggal 2 Maret 2023, Akta No: 1 tanggal 01 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU.AH.01.03-0051691 tanggal 01 Maret 2024, perubahan terakhir Akta No: 21 tanggal 3 Juli 2024 yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-AH.01.09-0222171 tanggal 04 Juli 2024, **dan berdasarkan Surat Kuasa No: B. 1059/DIR/KPH/XII/2023**, oleh karena itu sah menurut hukum bertindak untuk dan atas nama **PT Asuransi BRI Life**, berkedudukan di Gedung Graha Irama Lantai 5, 7, dan 15, Jl. H.R Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2, Jakarta Selatan, 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE** sebagai Direktur **PT. DISA PRIMA PRIMA** didirikan berdasarkan Akta nomor 14, tanggal 19 (Sembilan Belas) 05 (Mei) 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima), dibuat dihadapan Rita Sutandio, S.H , Sarjana Hukum, Notaris di Kota Probolinggo, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0039865.AH.01.01. Tahun 2025 tertanggal 19 (Sembilan Belas) 05 (Mei) 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Lima) selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :
 - a. **Rumah Sakit Dharma Husada Probolinggo** dengan izin operasional Rumah Sakit

Hlm. 1 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Commented [RI1]: LGL BRIL:
Agar tanggal dan tempat dicantumkan sesuai dengan penandatanganan aktual dilakukan.

Nomor 446/001/425/117/RS.KELAS D/2021 tertanggal 13 April 2021 diwakili oleh dr. Rosid Achmad, Sp.PK sebagai Direktur Rumah Sakit Dharma Husada yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 10 Kota Probolinggo

untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara masing-masing disebut "**Pihak**".

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu perusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin dari Kementerian Keuangan No: KEP-38/KM.10/2009 Tanggal 20 Maret 2009, yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK).
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sarana/fasilitas layanan kesehatan dengan yang telah memperoleh izin sebagai Rumah Sakit dari ____ No: ____ tanggal ____ (kelas serta Daerah disesuaikan dengan bentuk perijinannya).
- c. Bahwa dalam rangka pemberian layanan kesehatan dan obat bagi Peserta **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam penyediaan pelayanan kesehatan dan obat.
- d. Bahwa **PARA PIHAK** telah menyepakati pokok-pokok kerja sama sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan [*] Nomor: [*] tanggal [*] bulan [*] tahun [*]. (hapus jika tdk ada, namun MOM tetap dilampirkan menjadi satu dengan scan pks yang telah ttd 2 belah pihak)

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Pelayanan Kesehatan dan Obat Bagi Peserta Asuransi PT Asuransi BRILife (Perjanjian) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN

1. Definisi dan Pengertian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini ditentukan sebagai berikut:
 - a. **Alat kesehatan** adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
 - b. **Aplikasi BRILIFE-Care** adalah sistem informasi milik **PIHAK PERTAMA** yang diakses dan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA**, mulai dari tahap awal pelayanan hingga tahap penagihan Klaim.
 - c. **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan** adalah Badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-

Hlm. 2 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

- d. **Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai (BAHP)** adalah bahan dan Alat Kesehatan yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka melakukan diagnosa, pengobatan, dan perawatan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- e. **Berkas Elektronik** adalah berkas/dokumen pengajuan Klaim berupa *hardcopy*/berkas fisik yang dialihmediakan kedalam bentuk elektronik (*softcopy*) yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui Aplikasi BRILIFE-Care.
- f. **Bulan Pelayanan** adalah bulan sesuai tanggalan gregorius (berdasarkan kalender masehi) di mana **PIHAK KEDUA** memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta.
- g. **Faktor Pelayanan** adalah faktor pengali harga obat yang diberikan terhadap harga obat yang diresepkan, dimana besarnya diatur dalam ketentuan Formularium Obat Nasional (Fornas) yang berlaku atau sesuai kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
- h. **Formularium Nasional (Fornas)** adalah daftar obat yang wajib tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Fornas disusun oleh Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional.
- i. **Formularium Rumah Sakit** adalah obat yang pengadaannya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan diresepkan oleh dokter **PIHAK KEDUA** kepada Peserta.
- j. **Formulir Pengajuan Klaim (FPK)** adalah formulir standar **PIHAK PERTAMA**, yang wajib diisi oleh **PIHAK KEDUA** dan disertakan pada saat pengajuan Klaim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- k. **Hari Kalender** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius (berdasarkan kalender masehi).
- l. **Hari Kerja** adalah hari selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional di mana **PIHAK PERTAMA** beroperasi pada jam 08.00 – 17.00 waktu setempat.
- m. **Hari Rawat** adalah perhitungan jumlah Hari Rawat Inap Peserta di **PIHAK KEDUA** yaitu: dimulai dari tanggal masuk sampai dengan tanggal keluar dengan ketentuan apabila tanggal keluar sama dengan tanggal masuk, maka dihitung sebagai 1 (satu) Hari Rawat inap atau perhitungan rawat inap lain yang disepakati antara **PARA PIHAK** secara kasus per-kasus.
- n. **Hospital Liaison Officer (HLO)** adalah pegawai **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk sebagai penghubung antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** dan memiliki tugas termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian informasi tentang jadwal praktik, hak dan kewajiban Peserta serta menangani keluhan Peserta.

Hlm. 3 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- o. **Instalasi Farmasi (IFRS)** adalah penyedia jasa farmasi **PIHAK KEDUA**.
- p. **Indonesian-Case Based Group (INA-CBG)** adalah tarif klaim yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas paket pelayanan kesehatan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
- q. **Jenis Pelayanan (Jenpel)** adalah daftar pelayanan kesehatan dan tarif kesepakatan yang disepakati **PARA PIHAK** yang diatur dalam Lampiran Perjanjian ini.
- r. **Kartu BRILIFE** adalah bukti keikutsertaan pertanggungan asuransi Peserta di **PIHAK PERTAMA** dengan logo BRILIFE dan/atau dengan logo *Co-Branding* BRILIFE dengan pihak ketiga baik berbentuk fisik maupun dalam bentuk virtual.
- s. **Kelas Perawatan** adalah fasilitas Rawat Inap termasuk pelayanan obat yang menjadi hak Peserta sesuai dengan plan pada Kartu BRILIFE yang dimiliki Peserta.
- t. **Kasus Gawat Darurat (emergency)** adalah suatu kasus/gangguan mendadak yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/ atau kecacatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- u. **Klaim** adalah uang penggantian yang dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pelayanan kesehatan dan/ atau obat yang diberikan kepada Peserta.
- v. **Manfaat Pelayanan** adalah pelayanan kesehatan yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini atau ketentuan lain yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** dengan pemegang polis.
- w. **Manfaat Top Up BPJS Kesehatan** adalah penjaminan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas biaya pelayanan kesehatan Peserta yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan sebagai penjamin asuransi kesehatan pertama sesuai dengan ketentuan polis.
- x. **Manfaat Top Up BRILIFE** adalah penjaminan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas biaya pelayanan kesehatan Peserta berdasarkan ketentuan **PIHAK PERTAMA**
- y. **PRO (Provider Relation Officer)** adalah pegawai **PIHAK PERTAMA** yang ditunjuk berhubungan dengan **PIHAK KEDUA**, dengan tugas antara lain untuk mengendalikan kualitas dan mutu pelayanan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini.
- z. **Pelayanan Gawat Darurat (emergency)** adalah Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yang harus diberikan secepatnya pada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi risiko kematian atau cacat.

Commented [AC2]: Tarif-tarif yang disepakati oleh kedua belah pihak

Hlm. 4 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- aa. **Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)** adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjutan. FKRTL dapat berupa rumah sakit umum, rumah sakit khusus, atau klinik utama.
- bb. **Pelayanan One Day Care** adalah pelayanan atau tindakan pembedahan atau perawatan darurat yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat **PIHAK KEDUA** terhadap kondisi penyakit tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga ahli kesehatan dengan atau tanpa anestesi paling sedikit enam jam serta Peserta tanpa harus rawat inap.
- cc. **Pemegang Polis** adalah institusi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau yang bukan berbentuk badan hukum yang mengikatkan diri dengan **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan perlindungan asuransi kesehatan.
- dd. **Pemeriksaan Penunjang Diagnostik** adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosa sesuai indikasi medis.
- ee. **Persalinan** adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun lahir dengan memerlukan tindakan medis baik operatif dan non operatif.
- ff. **Peserta** adalah orang-perorangan yang terdaftar sebagai Peserta asuransi kesehatan **PIHAK PERTAMA**.
- gg. **Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan** adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik yang meliputi Rawat Jalan Lanjutan, Rawat Inap Lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
- hh. **Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif** adalah pemberian pelayanan kesehatan Rawat Jalan nonreguler di Rumah Sakit yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis atau subspesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar.
- ii. **Produk BRILIFE** adalah produk asuransi kesehatan yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**, yang terdiri dari:
Produk BRILIFE Managed Care terdiri dari New Managed Care yang dibedakan menurut plan yang terdiri dari: **Diamond, Ruby, Shapphire, dan Emerald** sebagaimana tertera di Kartu Peserta BRILIFE.
- jj. **Provider** adalah sarana/fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi Peserta berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan. Provider terbagi atas:
- 1) **Provider Tingkat Pertama**: sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar/umum yang menyeluruh, dan mengutamakan

Hlm. 5 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

pelayanan promotif dan preventif yang meliputi klinik dan praktek dokter umum yang terdiri atas:

- a) Provider Tingkat Pertama yang hanya bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**, atau
 - b) Provider Tingkat Pertama yang hanya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan selanjutnya disebut RJTP (Rawat Jalan Tingkat Pertama), atau
 - c) Provider Tingkat Pertama yang bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** dan sekaligus BPJS Kesehatan, dan
- 2) Provider Tingkat Lanjutan: sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan spesialis dan subspesialis untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi Medis, dan/ atau pelayanan medis lainnya baik pelayanan rawat jalan maupun rawat inap yang meliputi praktik dokter spesialis, klinik spesialis, dan Rumah Sakit yang terdiri atas:
- a) Provider Tingkat Lanjutan yang hanya bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**, atau
 - b) Provider Tingkat Lanjutan yang bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** dan sekaligus BPJS Kesehatan
- kk. **Provider Irisan** adalah Provider mitra dari **PIHAK PERTAMA** yang terdaftar sebagai sarana pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan.
- ll. **Rekam Medis** adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan Provider kepada Peserta.
- mm. **Rawat Inap (RI)** adalah pelayanan yang bersifat spesialis/subspesialis untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi Medis dan/atau pelayanan medis lainnya, pada Provider Tingkat Lanjutan yang mana Peserta dirawat inap di ruang perawatan/perawatan khusus paling sedikit 1 (satu) hari.
- nn. **Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)** adalah pelayanan kesehatan yang bersifat spesialis atau subspesialis tanpa menginap di ruangan perawatan dan dilaksanakan pada Provider Tingkat Lanjutan sebagai Rujukan dari Provider Tingkat Pertama.
- oo. **Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)** adalah pelayanan kesehatan yang bersifat spesialis atau subspesialis tanpa menginap di ruangan perawatan dan dilaksanakan pada Provider Tingkat Lanjutan sebagai Rujukan dari Provider Tingkat Pertama.
- pp. **Rehabilitasi Medis** adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi Rehabilitasi Medis dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, dan bimbingan sosial medik.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- qq. **Rujukan** adalah sistem aturan pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik antar Provider Tingkat Pertama dengan Provider Tingkat Lanjutan.
- rr. **Rumah Sakit** adalah sarana/fasilitas upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan secara komprehensif serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
- ss. **Surat Jaminan** adalah dokumen keabsahan Peserta yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai syarat untuk memperoleh pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA** berupa:
- 1) Surat Jaminan Pelayanan (SJP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** pada Aplikasi BRILIFE-Care untuk eligibilitas Peserta Produk BRILIFE Managed Care dan Produk BRILIFE Managed Care Skema I-Pro, dan/atau
 - 2) Surat Eligibilitas Peserta (SEP) yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.
- tt. **Telemedicine** adalah sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau perubahannya dari waktu ke waktu.
- uu. **Tindakan Medis** adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
- vv. **Verifikasi Klaim** adalah upaya pemeriksaan kelengkapan/kebenaran berkas kelayakan Klaim yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**/Peserta.

2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam Perjanjian ini bahwa:

- a. Judul suatu Pasal atau ayat semata-mata hanya untuk kemudahan saja dan tidak dapat dianggap mempunyai arti dalam menafsirkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- b. Kata-kata dalam bentuk tunggal dapat mencakup bentuk jamak dan sebaliknya.
- c. Kata yang menyatakan kata ganti orang dapat mencakup kata ganti benda, termasuk perseorangan, perusahaan, kemitraan, asosiasi, bentuk kerja sama lainnya, pemerintahan dan badan-badan pemerintah.
- d. Setiap dan semua lampiran yang disebut dan dilampirkan pada Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bekerja sama dalam penyediaan pelayanan kesehatan kepada Pemegang Polis dan Peserta dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Hlm. 7 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta.

PASAL 3

RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR PELAYANAN

1. Ruang lingkup Perjanjian ini adalah mengatur mekanisme dan hal-hal lainnya terkait prosedur pelayanan kesehatan untuk Peserta.
2. Ruang lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan yang dimaksud Perjanjian ini akan diatur lebih rinci sebagaimana diatur dalam **Lampiran I** tentang Produk BRILIFE Managed Care dan Produk BRILIFE Managed Care dengan Manfaat *Top Up* BPJS Kesehatan.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Melihat dan mengakses kartu status dan/atau Rekam Medis dan berkas fisik atas pelayanan Peserta yang dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui pertukaran data elektronik, *softcopy* atau *hardcopy* dalam hal diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Melakukan peninjauan atas pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta dengan cara, termasuk tetapi tidak terbatas pada, mendapatkan data dan informasi tentang fasilitas **PIHAK KEDUA** dan kunjungan Peserta.
 - c. Melakukan audit atau pemeriksaan terhadap **PIHAK KEDUA** apabila terdapat dugaan penyalahgunaan pelayanan kesehatan dan/atau surat pesanan obat/resep kepada Peserta atau non Peserta.
 - d. Memberikan teguran atau peringatan lisan dan/atau tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan berdasarkan Perjanjian ini oleh **PIHAK KEDUA**.
 - e. Memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** berdasarkan Pasal 12 dalam Perjanjian ini.
 - f. Menerima data dan informasi termasuk namun tidak terbatas pada dokumen uji tuntas **PIHAK KEDUA**/Provider *due diligence* dalam rangka pemenuhan peraturan perundangan, Berkas Elektronik dan/ atau dokumen, data lainnya yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** secara benar, sah dan akurat baik melalui pertukaran data elektronik dan/ atau dokumen fisik, apabila diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - g. Menerima tagihan elektronik yang dihasilkan dari Aplikasi BRILIFE-Care yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** atas biaya pelayanan kesehatan dan obat bagi Peserta secara teratur setiap bulan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - h. Menerima dokumen untuk pengajuan Klaim sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA** yang diatur pada Perjanjian ini secara lengkap, benar dan sah.
 - i. Mendapatkan kepastian bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta sesuai indikasi medis dan standar serta prosedur pelayanan

Hlm. 8 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

kesehatan yang berlaku atau dengan mengutamakan prinsip kendali mutu dan kendali biaya serta pertanggungjawaban **PIHAK KEDUA** atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta dalam melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini.

- j. Menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** atas karyawan/pegawai **PIHAK KEDUA** yang bertanggung jawab atas Klaim kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini, termasuk pergantiannya dari waktu ke waktu.
 - k. Menerima dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas pada tagihan Klaim yang ditandatangani oleh perwakilan sah **PIHAK KEDUA** yang memiliki kapasitas, kewenangan serta cakap untuk melakukan hal tersebut.
 - l. Mendapatkan akses untuk menggunakan seluruh dokumen terkait dengan Klaim untuk kepentingan audit internal/eksternal.
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Membayar Klaim sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - b. Memberikan akses Aplikasi BRILIFE-Care yang sudah memiliki fitur untuk layanan produk Managed Care dan Indemnity kepada **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan pelayanan kesehatan Peserta BRILIFE.
 - c. Menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** atas karyawan/pegawai yang bertanggung jawab untuk menerima seluruh dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas pada tagihan pelayanan kesehatan Peserta sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 9 Perjanjian ini, termasuk pergantiannya dari waktu ke waktu.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menerima informasi tentang ruang lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan yang disediakan bagi Peserta.
 - b. Memperoleh pembayaran biaya pelayanan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian ini.
 - c. Mengakses Aplikasi BRILIFE-Care **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan pelayanan kesehatan Peserta.
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan **PIHAK PERTAMA** hak untuk mengakses dan/ atau melihat kartu status dan/ atau Rekam Medis dan bukti pelayanan Peserta baik secara pertukaran data elektronik, *softcopy* atau *hardcopy* apabila diperlukan.

Hlm. 9 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- b. Menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) sebagai syarat memperoleh pelayanan.
- c. Memberikan Manfaat Pelayanan dengan baik dan benar sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini.
- d. Melayani Peserta dengan baik sesuai indikasi medis dan standar serta prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku atau dengan mengutamakan prinsip kendali mutu dan kendali biaya, dan oleh karenanya bertanggungjawab penuh dalam kapasitasnya selaku pemberi pelayanan kesehatan kepada Peserta dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- e. Menjamin dan mengutamakan penulisan resep obat bagi Peserta yang berpedoman pada Formularium Obat Nasional (Fornas) dan Formularium Obat Rumah Sakit yang disepakati.
- f. Menjamin ketersediaan dan kecukupan obat-obatan yang tercakup dalam Formularium Obat Nasional (Fornas) dan Formularium Obat Rumah Sakit.
- g. Menyediakan dokter untuk kebutuhan Peserta sesuai dengan jam kerja dokter pada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan penggantinya dalam hal dokter yang disediakan berhalangan dan/ atau tidak lagi bekerja atau berpraktik di **PIHAK KEDUA**.
- h. Memastikan bahwa dokter yang bekerja atau berpraktik di **PIHAK KEDUA** memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku sebagai dokter dan mematuhi ruang lingkup dan prosedur pelayanan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- i. Mengajukan tagihan elektronik luaran aplikasi online yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** atas biaya pelayanan kesehatan dan obat bagi Peserta secara teratur setiap bulan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- j. Dalam hal **PIHAK KEDUA** juga sebagai Provider Irisan maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pelayanan sesuai mekanisme Manfaat *Top Up* BPJS Kesehatan yang diatur dalam Perjanjian ini, menerbitkan SEP dan juga mengajukan tagihan elektronik dengan mekanisme *split billing* melalui INA-CBG.
- k. Menyediakan dokumen penagihan sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA** yang diatur pada lampiran Perjanjian ini secara lengkap, benar dan sah.
- l. Sewaktu-waktu menyediakan data dan informasi termasuk namun tidak terbatas pada dokumen uji tuntas **PIHAK KEDUA**/Provider *due diligence*, Berkas Elektronik dan/atau dokumen, data lainnya yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** secara benar, sah dan akurat baik melalui pertukaran data elektronik dan/atau dokumen fisik, apabila diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- m. Melakukan penyimpanan berkas dokumen fisik serta Berkas Elektronik dan/atau dokumen yang telah dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** selama 5 (lima) tahun sejak Bulan Pelayanan.
- n. Bersama-sama **PIHAK PERTAMA** atau secara sendiri melaksanakan program promotif dan preventif kepada Peserta.
- o. Menetapkan dan memastikan memiliki kesepakatan tarif dan kerja sama serta dengan Rumah Sakit yang berada di wilayah domisili **PIHAK KEDUA** ("Rumah Sakit Rekanan"), agar Peserta mendapatkan kepastian Manfaat Pelayanan baik untuk penunjang diagnostik atau tindakan pelayanan oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal dengan sebab apapun **PIHAK KEDUA** tidak dapat memberikan Manfaat Pelayanan

Commented [AC3]: Wajib meminta softcopy data obat

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

dengan merujuk Peserta ke Rumah Sakit Rekanan, biaya yang timbul atas Rujukan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

- p. **PIHAK KEDUA** dengan usaha terbaiknya wajib menjaga kredibilitas dan reputasi **PIHAK PERTAMA** sebagai rekanan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pencegahan atas seluruh pernyataan yang cenderung memberikan dampak buruk pada kredibilitas dan reputasi **PIHAK PERTAMA** yang dinyatakan oleh **PIHAK KEDUA**/setiap afiliasi/setiap pegawai dan setiap dokter sehubungan dengan ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian ini.
- q. Memberikan hak akses bagi **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan seluruh dokumen elektronik terkait Klaim untuk kepentingan audit internal/eksternal.

PASAL 6 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul akibat dari Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 TARIF PELAYANAN KESEHATAN

1. Tarif pelayanan kesehatan bagi Peserta adalah tarif yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
2. **Besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Perjanjian ini.**
3. Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, hanya dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menarik biaya apapun terhadap Peserta sepanjang Pelayanan Kesehatan yang diberikan masih tercakup dalam ruang lingkup serta memenuhi prosedur Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Commented [AC4]: Disesuaikan dengan masa kontrak RS

PASAL 8 BIAYA PELAYANAN OBAT

Biaya Pelayanan Obat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini diatur dalam **Lampiran 1** Perjanjian ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 9 TATA CARA PENGAJUAN KLAIM DAN PEMBAYARAN

1. Tata cara Pengajuan Klaim dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini diatur dalam **Lampiran 1** Perjanjian ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Hlm. 11 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui transfer ke rekening:

Nama Bank : PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk
Atas Nama : PT. Disa Prima Medika
No Rekening : 055401000454303
No NPWP : 1000 0000 0251 6066
Nama atas NPWP : DISA PRIMA PRIMA

PASAL 10

TAHAP PENINJAUAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti tahap peninjauan dan penilaian kesiapan sebagai Provider yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan pemberitahuan tertulis hasil peninjauan dan penilaian yang dilakukan beserta rekomendasi yang diperlukan kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** dinyatakan tidak lulus tahap peninjauan dan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan peninjauan ulang atas Perjanjian ini atau memutuskan untuk mengakhiri atau melanjutkan dengan melakukan perubahan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.

PASAL 11

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ____ bulan ____ tahun ____ dan berlaku untuk jangka waktu ____ tahun atau berakhir pada tanggal ____ bulan ____ tahun ____ ("**Jangka Waktu Perjanjian**").
2. Kerja Sama ini akan di evaluasi kedua belah pihak setiap 3 bulan sekali.
3. Jangka Waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan kehendak untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian tersebut wajib disampaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
4. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari salah satu Pihak kepada Pihak yang lainnya untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
5. Dalam hal berakhirnya Perjanjian ini karena tidak diperpanjang lagi, mengharuskan masing-masing Pihak menyelesaikan kewajibannya masing-masing yang masih ada dan/ atau tertunda terhadap Pihak lainnya sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian ini.

Commented [R15]: LGL BRIL:
Agar dilengkapi sesuai dengan kesepakatan para pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 12

SANKSI

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** terbukti secara nyata melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak melayani Peserta dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kewajibannya sebagai Provider dan/ atau sesuai Perjanjian ini, dan/ atau
 - b. Tidak memberikan fasilitas, pelayanan kesehatan dan obat kepada Peserta dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Plan/Manfaat, dan/ atau
 - c. Memungut biaya tambahan kepada Peserta diluar kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian, dan/ atau
 - d. maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menanggguhkan pembayaran atas tagihan/*invoice* yang telah diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, sampai adanya penyelesaian yang dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan tindakan atau kesalahan atau malpraktik yang menimbulkan kerugian bagi Peserta sehingga mengakibatkan Peserta menuntut **PIHAK KEDUA** dan/ atau **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala bentuk tuntutan, ganti rugi dan/ atau tanggung jawab lainnya yang diajukan oleh Peserta dan/atau pihak lainnya serta wajib mengganti **PIHAK PERTAMA** atas segala bentuk kerugian yang timbul.
3. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian ini padahal **PIHAK PERTAMA** telah menyetujui tagihan/*invoice* **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali. Apabila surat teguran ketiga tidak mendapatkan tanggapan dari **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** berhak memutuskan Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.

PASAL 13

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian berakhir dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) Hari Kerja.
 - b. Izin usaha atau operasional salah satu Pihak dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha, operasional atau ijin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi.
 - c. **PIHAK KEDUA** (Provider klinik/apotek) berhenti praktik atau menutup kegiatan usahanya yang disebabkan karena kehendaknya sendiri.
 - d. Dalam hal **PIHAK KEDUA** pindah praktik ke lokasi yang tidak disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** yang berlaku untuk Provider klinik/apotek.

Hlm. 13 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- e. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak lulus dalam tahap Peninjauan sesuai ketentuan pada Pasal 10 Perjanjian ini.
 - f. **PIHAK PERTAMA** dinyatakan pailit oleh pengadilan.
 - g. **PIHAK PERTAMA** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi.
2. Kecuali berdasarkan ketentuan *Force Majeure*, maka dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelumnya.
 3. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim/Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/mengakhiri suatu Perjanjian.
 4. Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau diakhiri maka tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

PASAL 14 PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai Provider yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.

PASAL 15 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta sesuai dengan Perjanjian ini dan standar pelayanan kesehatan dan kode etik profesi yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dan bertanggung jawab secara penuh terhadap segala kerugian dan/atau tuntutan yang diajukan oleh Peserta dan/atau Pemegang Polis dan/atau pihak ketiga lainnya atas segala tindakan pelayanan kesehatan termasuk dalam hal terjadi kesalahan atau malpraktik atas Peserta yang dilakukan oleh dan/atau terjadi di **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin untuk menerapkan dan melaksanakan strategi *anti-fraud* dalam melaksanakan kerja sama untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan, pengajuan Klaim yang menimbulkan kerugian bagi **PIHAK PERTAMA** dan bertanggung atas segala akibat yang timbul.

Hlm. 14 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

4. **PIHAK KEDUA** dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa:
- Seluruh tagihan atas pelayanan kesehatan Peserta yang ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA** beserta dokumen-dokumen pendukungnya baik yang disampaikan dalam bentuk berkas fisik (*hardcopy*) maupun Berkas Elektronik merupakan dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - Setiap dokumen yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan ditandatangani oleh perwakilan sah.

PASAL 16
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- Keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **Pihak** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **Pihak** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **Pihak** lainnya. **Pihak** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- Apabila *Force Majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh **Pihak** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 17
TELEMEDICINE

Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyediakan layanan *Telemedicine* maka:

- PIHAK KEDUA** menjamin bahwa **PIHAK PERTAMA** diprioritaskan untuk mendapatkan pelayanan *Telemedicine* bagi Peserta.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Prosedur Pelayanan Kesehatan melalui *Telemedicine* diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** pada **Lampiran 1** Perjanjian ini.

Commented [R16]: LGL BRIL:
Agar dapat disesuaikan dengan layanan RS.

PASAL 18 KERAHASIAAN

1. Informasi dengan hak kepemilikan dan rahasia ("**Informasi Rahasia**") sebagaimana digunakan dalam Perjanjian ini, merujuk pada setiap dan segala informasi yang bersifat rahasia termasuk namun tidak terbatas pada informasi lisan maupun tertulis atau dalam bentuk visual, elektronik atau nyata yang berkaitan dengan suatu Pihak atau dengan produk, resume medis, data pasien, teknologi, rahasia dagang, proses formula, sistem, data, *know-how* perkembangan, ciptaan, teknik, hak kekayaan intelektual atau hal-hal bisnis lainnya dari **PARA PIHAK**.
2. Sehubungan dengan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Pihak yang menerima Informasi Rahasia ("**Penerima**") berkewajiban kepada Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia ("**Pengungkap**") (i) untuk menggunakan Informasi Rahasia semata-mata untuk tujuan Perjanjian ini dan (ii) untuk menjaga dan tidak membuka Informasi Rahasia ke pihak ketiga manapun selain kepada kepada Direktur, Karyawan atau wakil sah "**Perwakilan**", kecuali untuk informasi yang:
 - a. Telah diketahui atau telah secara sah dimiliki oleh Penerima sebelum diungkapkan oleh Pengungkap berdasarkan Perjanjian ini dan tidak diperoleh atau didapatkan secara langsung dari Pengungkap.
 - b. Telah diketahui umum atau sudah menjadi milik penerima pada saat pengungkapan dilakukan atau menjadi diketahui umum bukan karena perbuatan, kelalaian atau kesalahan Penerima mengenai kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
 - c. Dikembangkan secara independen oleh Penerima tanpa menggunakan atau merujuk Informasi Rahasia Pengungkap.
 - d. diperoleh oleh Penerima dari suatu pihak ketiga yang tidak melanggar kewajiban kerahasiaan apapun.
 - e. di mana Penerima telah menerima pemberitahuan secara tertulis dari Pengungkap bahwa Informasi Rahasia sudah tidak perlu lagi dijaga kerahasiaannya. dan
 - f. Penerima diisyaratkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia sesuai dengan perintah pengadilan atau atas perintah lembaga peradilan yang lainnya atau instansi pemerintah yang berhak, Penerima akan segera, setelah menerima pemberitahuan permintaan pembukaan Informasi Rahasia, memberikan pemberitahuan kepada Pengungkap akan adanya permintaan pembukaan kerahasiaan tersebut dan bekerja sama sepenuhnya dengan Pengungkap, sehingga memberikan kepada Pengungkap kesempatan yang wajar untuk membatasi jenis pengungkapan atas Informasi Rahasia.
3. **PARA PIHAK** harus menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sepenuhnya selama Perjanjian dan untuk masa 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini. Penerima Informasi Rahasia tidak boleh membuka atau menggunakan Informasi Rahasia tersebut untuk tujuan lain selain yang diatur dalam Perjanjian ini. **PARA PIHAK** harus menetapkan

Hlm. 16 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

dan menjaga langkah-langkah pengamanan yang cukup untuk melindungi Informasi Rahasia dari penggunaan yang tidak sah.

4. Penerima mengetahui bahwa pelanggaran material olehnya berdasarkan Perjanjian ini dapat mengakibatkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki kepada Pengungkap dan setuju bahwa upaya hukum atas pelanggaran material tersebut mungkin tidak memadai. **PARA PIHAK** memahami dan setuju bahwa ganti rugi uang mungkin bukan upaya pemulihan yang memadai untuk setiap pelanggaran terhadap Perjanjian ini oleh Penerima dan Pengungkap berhak atas penyelesaian yang adil, termasuk putusan dan pelaksanaan tertentu, sebagai upaya pemulihan terhadap pelanggaran tersebut oleh Pihak Penerima, Upaya pemulihan tersebut tidak akan dianggap sebagai upaya pemulihan eksklusif untuk pelanggaran ganti rugi, proses beracara hukum, tuntutan, kewajiban dan pengeluaran Perjanjian ini namun akan merupakan tambahan terhadap pemulihan lainnya yang tersedia berdasarkan hukum.

PASAL 19 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI**

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan sepanjang memungkinkan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 20 **CONTACT PESON**

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **Pihak** kepada **Pihak** lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, faksimili atau email dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA:

Contact person untuk Perjanjian Kerja Sama, menghubungi:

Nama : Ni Nyoman Ayu Tri Utami

Unit Kerja : Divisi *Healthcare Ecosystem*

No. Telp. :

No. HP : 087861510981

Email : nyoman.ayu@brilife.co.id

Alamat PKS : Gedung Graha Irama

Jl. HR. Rasuna Said Blok X1 Kav.1-2

Kuningan, Jakarta Selatan, 12950

Commented [SR57]: Diisi Sesuai dengan PIC masing-masing Provider

Hlm. 17 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Contact person untuk Pelayanan Kesehatan/Jaminan peserta menghubungi Pelayanan 24 Jam di nomor:

Call Center/Penjaminan: 150187
Email: contact.center@brilife.co.id

Contact person Bagian Penagihan/Pengiriman Berkas Tagihan (Klaim Tagihan) dan Konfirmasi Pembayaran, menghubungi:

Nama : Up. Klaim Tagihan Provider
Email : invoice@brilife.co.id
Alamat Klaim : **Kantor Layanan Semarang**
PT Asuransi BRI Life
Up. Bagian Klaim Tagihan
Jl. Gajah Mada No. 170, Semarang
Jawa Tengah

PIHAK KEDUA:

Contact person untuk Perjanjian Kerja Sama, menghubungi:

Nama : _____
Unit Kerja : _____
No. Telp. : _____
No. HP : _____
Email : _____
Alamat : _____

Contact person untuk Pelayanan Kesehatan, menghubungi:

Nama : _____
Unit Kerja : _____
No. Telp. : _____
No. HP : _____
Email : _____

Contact person untuk Kelengkapan Berkas Tagihan dan Konfirmasi Pembayaran, menghubungi:

Nama : _____
Unit Kerja : _____
No. Telp. : _____
No. HP : _____
Email : _____

Commented [SR58]: Dilengkapi sesuai dengan PIC dari RS

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui teleks atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman teleks, konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimili dan *sent* pada pengiriman email.

Hlm. 18 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

3. Dalam hal salah satu Pihak melakukan perubahan domisili/alamat maka **PARA PIHAK** wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelumnya.

PASAL 21
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Bahwa tidak terlepas dari Pasal 19 tentang Kerahasiaan diperlukan ketentuan khusus mengenai Pelindungan Data Pribadi yang menjadi kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
2. Bahwa **PARA PIHAK** hanya akan melakukan Pemrosesan Data Pribadi Peserta sesuai dengan tujuan Perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** hanya akan mengungkapkan Data Pribadi Peserta Pertanggungungan kepada karyawannya atau agen atau subkontraktornya yang tunduk pada kewajiban kerahasiaan yang mengikat sehubungan dengan Data Pribadi.
4. **PARA PIHAK** hanya akan menyediakan Data Pribadi Peserta kepada personel yang memerlukan akses ke Data Pribadi tersebut untuk memberikan layanan berdasarkan Perjanjian ini.
5. **PARA PIHAK** harus menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang sesuai untuk memastikan tingkat keamanan yang sesuai dengan risiko untuk melindungi Data Pribadi dari kehilangan, kehancuran, atau kerusakan dan setiap Pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum.
6. Apabila **PARA PIHAK** menerima permintaan dari Peserta yang menggunakan haknya berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** harus memenuhi hak tersebut.
7. **PARA PIHAK** harus saling segera memberitahukan satu sama lain mengenai Pelanggaran Data Pribadi atau diterimanya pemberitahuan dari Otoritas Pengawas.
8. **PARA PIHAK** harus melakukan upaya yang wajar untuk mengidentifikasi penyebab Pelanggaran Data Pribadi tersebut dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menentukan penyebabnya dan untuk mencegah Pelanggaran Data Pribadi tersebut terulang kembali.
9. Selama jangka waktu ini, **PARA PIHAK** satu sama lain harus menyediakan semua informasi yang relevan yang secara wajar diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Perjanjian ini dan hukum atau peraturan yang berlaku, dan harus mengizinkan dan bekerja sama secara wajar dengan audit, termasuk inspeksi.

Hlm. 19 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 22
KETENTUAN TENTANG KORUPSI DAN PENYUAPAN

1. **PARA PIHAK** tidak melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang menyebabkan **PARA PIHAK** dan/atau afiliasinya melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang anti korupsi dan/atau peraturan lain yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil otoritas publik, rekan-rekan **PARA PIHAK**, keluarga atau teman dekat.
2. **PARA PIHAK** setuju bahwa tidak akan menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi kepada karyawan, setiap perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain atau menerima atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain, hadiah atau manfaat baik berupa uang atau lainnya yang mana penerima menurut hukum bukanlah pihak yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasil, atau pelaksanaan [Perjanjian](#) ini.
3. **PARA PIHAK** wajib segera memberitahukan satu sama lain, jika terjadi kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan hasil negosiasi atau pelaksanaan [Perjanjian](#) ini.
4. [Perjanjian](#) ini [berakhir](#) apabila terdapat pembayaran atau pemberian hadiah yang tidak wajar yang dilakukan oleh salah satu pihak sebagaimana disebutkan dalam [Perjanjian](#) ini atau jika salah satu pihak memiliki alasan untuk meyakini bahwa pembayaran atau pemberian hadiah tersebut dilakukan oleh pihak lainnya, hal mana harus dibuktikan terlebih dahulu.

PASAL 23
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI
SENJATA PEMUSNAHAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

1. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan nasabah sehubungan dengan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Penanganan Proliferasi Senjata Pemusnahan di sektor jasa keuangan (PPPSPM) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila **PARA PIHAK** maupun pejabat yang berwenang meminta informasi yang berkaitan dengan program APUPPT dan PPPSPM tersebut, maka **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan data-data yang berkaitan dengan program APUPPT dan PPPSPM tersebut dengan ketentuan bahwa permintaan atas informasi nasabah tersebut harus dibuat secara tertulis oleh Pihak yang meminta informasi.

Hlm. 20 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**PASAL 24
LAIN-LAIN**

1. **Keterpisahan**

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.

2. **Penugasan**

Perjanjian ini mengikat dan menjamin hak-hak dan kewajiban bagi **PARA PIHAK**, penerus dan wakilnya.

3. **Perubahan**

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

4. **Keseluruhan Perjanjian**

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman di antara **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan pokok Perjanjian ini dan menggantikan perjanjian atau pemahaman sebelumnya, baik lisan maupun tertulis, yang berkaitan dengan pokok masalah Perjanjian. **PARA PIHAK** masing-masing menyatakan memiliki kapasitas hukum untuk melaksanakan Perjanjian ini dan melakukan kewajibannya dan telah memperoleh semua pendaftaran yang diperlukan dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud di dalam Perjanjian ini.

5. **Batasan Tanggung Jawab**

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA** kepada Peserta yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar syarat ketentuan pada Perjanjian ini dan terhadap kerugian maupun tuntutan yang diajukan oleh Peserta kepada **PIHAK KEDUA** yang disebabkan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan tanggung jawab profesinya seperti, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kesalahan dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan, kesalahan dalam memberikan indikasi medis atau kesalahan dalam memberikan Tindakan Medis.

6. **Hukum Yang Berlaku**

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PT ASURANSI BRI LIFE

PIHAK KEDUA
PT/YAYASAN/RS _____

Anna Novy Handayani
Project Manager Healthcare

(dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE)
(Direktur)

Commented [AAP9]: Khusus Pejabat berwenang

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

LAMPIRAN I

Nomor:

Nomor:

PETUNJUK TEKNIS
TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN
PRODUK BRILIFE MANAGED CARE
DI RUMAH SAKIT

Commented [SRS10]: Dilengkapi sesuai dengan nama rs

I. Kepesertaan

- A. Peserta yang dapat dilayani di **PIHAK KEDUA** adalah Peserta BRILIFE atau Peserta dengan Manfaat *Top Up* BPJS Kesehatan yang mempunyai dan membawa Kartu BRILIFE/ kartu sementara/ *e-Card* pada Aplikasi **PIHAK PERTAMA** dari *handphone* Peserta dengan status aktif pada Aplikasi BRILIFE-Care yang divalidasi dengan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor).
- B. Plan Peserta yang dapat dilayani di **PIHAK KEDUA** adalah Plan Peserta sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** yaitu: **(hapus kolom plan yang tidak dikerjakan samakan)**

☐ Diamond	a. Region: Indonesia dan Internasional b. Rumah Sakit: Rumah Sakit Luar Negeri (Malaysia & Singapura), Rumah Sakit Eksklusif di Indonesia, Rumah Sakit Swasta & Pemerintah di Indonesia. c. Tipe Kamar: VVIP. d. Manfaat Utama: RJP, RJL, RI, Obat. e. Manfaat Tambahan: Paket Bersalin, Paket Tunjangan Tambahan (Suplemen), Hemodialisis, Kedokteran Nuklir, Peralatan Canggih. f. Manfaat Spesial: Operasi jantung, operasi ginjal, operasi paru-paru, operasi dengan menggunakan peralatan canggih. g. Services: Tanpa surat rujukan.
☐ Ruby	b. Region: Indonesia c. Rumah Sakit: Rumah Sakit Eksklusif di Indonesia, Rumah Sakit Swasta & Pemerintah di Indonesia d. Tipe Kamar: VIP, I, II e. Manfaat Utama: RJP, RJL, RI, Obat f. Manfaat Tambahan: Paket Bersalin, Paket Tunjangan Tambahan (Suplemen), Hemodialisis, Kedokteran Nuklir, Peralatan Canggih. h. Manfaat Spesial: Operasi jantung, operasi ginjal, operasi paru-paru, operasi dengan menggunakan peralatan canggih. i. Services: Dengan surat rujukan

Hlm. 23 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



II. Pelayanan kesehatan

A. Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang Lingkup Pelayanan di RS terdiri atas:

1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL).
2. Rawat Inap (RI).
3. Pelayanan Obat-obatan.
4. Pelayanan Khusus dan Canggih (*untuk Produk Diamond, dan Ruby*).
5. Pelayanan Gawat Darurat (*emergency*).
6. Transfusi Darah.
7. Manfaat *Top Up BPJS Kesehatan*

B. Penjelasan Ruang Lingkup Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL):
 - a. Konsultasi medis, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis/sub spesialis.
 - b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sederhana sampai canggih.
 - c. Tindakan Medis.
 - d. Rehabilitasi medis.
 - e. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
 - f. Pemberian obat-obatan dengan mengutamakan Formularium Nasional (Fornas) dan/atau Formularium Rumah Sakit.
 - g. Pemberian obat-obatan sitostatika atau kanker mengacu pada Formularium Nasional (Fornas) dan/ atau Formularium Rumah Sakit.
 - h. Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAHP).

Hlm. 25 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- i. Pelayanan Gawat Darurat dengan kriteria *emergency*.
 - j. Pemberian Rujukan ke Provider lebih tinggi.
 - k. Pemberian Rujukan balik ke tingkat pertama.
 - l. Pelayanan *One Day Care*.
 - m. Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyediakan layanan *Telemedicine*, maka lingkup pelayanan sebagai berikut:
 - 1) Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan pengobatan oleh dokter yang terdaftar di **PIHAK KEDUA**.
 - 2) Pelaksanaan *Telemedicine* Rawat Jalan Tingkat Lanjutan hanya untuk kasus kronis, kasus kehamilan dan poli anak. Pelayanan *Telemedicine* dengan diagnosa penyakit kronis harus mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - 3) Pemberian surat Rujukan antar spesialis/sub spesialis, fasilitas penunjang diagnostik atau rawat inap tidak berlaku untuk pelayanan *Telemedicine*.
2. Pelayanan Rawat Inap (RI):
- a. Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter spesialis/ sub-spesialis.
 - b. Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan sesuai hak Peserta.
 - c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sederhana sampai canggih.
 - d. Tindakan Medis yang bersifat diagnostik, terapeutik dan operatif.
 - e. Rehabilitasi medis.
 - f. Keadaan darurat akibat kecelakaan, baik akibat kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja.
 - g. Pemberian obat-obatan sesuai dengan mengutamakan Formularium Nasional (Fornas) atau sesuai Formularium Rumah Sakit yang telah disepakati.
 - h. Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai (BAHP).
 - i. Pelayanan transfusi darah.
 - j. Pemberian surat Rujukan.
3. Pelayanan Obat-obatan
- Meliputi pemberian semua jenis obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan medis, dapat diberikan dengan cara diminum/ disuntik/ dioles/ dihirup atau diteteskan yang berpedoman kepada Formularium Nasional (Fornas) dan/ atau Formularium Rumah Sakit yang telah disepakati **PARA PIHAK** dalam rangka penyembuhan, tidak termasuk obat-obatan yang masih merupakan percobaan/ hipotesa/riset. Pemberian obat sebagai tindak lanjut dari pelayanan yang diberikan pada berbagai jenjang pelayanan kesehatan:
- a. Obat Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)
 Pemberian obat berdasarkan resep obat yang dikeluarkan oleh dokter yang terdaftar sebagai dokter Spesialis/Sub spesialis di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** yang mengacu pada Formularium Nasional (Fornas) dan/atau Formularium Rumah Sakit serta ketentuan lainnya yang berlaku yang kemudian dapat diambil pada Instalasi Farmasi RS atau Apotek yang bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyediakan layanan *Telemedicine*, pemberian obat berdasarkan resep obat yang dikeluarkan oleh dokter yang terdaftar di **PIHAK KEDUA** yang mengacu kepada Formularium Nasional (Fornas) dan/ atau Formularium Rumah Sakit serta ketentuan lainnya yang berlaku dengan prosedur penyerahan obat sebagai berikut:

- 1) Dokter wajib menjelaskan jumlah dan jenis obat yang diberikan kepada Peserta BRILIFE pada ruang *chat/call/video call Telemedicine*.
 - 2) Obat akan diserahkan **PIHAK KEDUA** melalui pengiriman kepada alamat Peserta BRILIFE. Biaya pengiriman obat dapat ditagihkan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta BRILIFE.
- b. Obat Rawat Inap (RI)
- Obat Rawat Inap diberikan langsung oleh Dokter yang terdaftar sebagai Dokter Spesialis/Sub spesialis di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** yang mengacu kepada ketentuan dan daftar Formularium Nasional (Fornas) berlaku dan/ atau Formularium Rumah Sakit yang telah disepakati yang selanjutnya Obat dapat diambil pada Apotek atau Instalasi Farmasi (IFRS) yang bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**.
- Pelayanan Obat Rawat Inap sedapat mungkin dilakukan dengan sistem OUDD (One Unit Dispensing Dose) atau ODDD (One Day Dispensing Dose).
- c. Ruang lingkup pelayanan termasuk tata cara/mekanisme pengambilan obat sitostatika atau obat-obatan kanker lainnya mengacu kepada ketentuan pada buku Formularium Nasional (Fornas) dan/atau Formularium Rumah Sakit yang berlaku.
- d. Ruang lingkup pelayanan termasuk tata cara/mekanisme pengambilan obat khusus dan albumin mengacu kepada ketentuan pada buku Formularium Nasional (Fornas) dan/atau Formularium Rumah Sakit yang berlaku atau berdasarkan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

4. Pelayanan Khusus dan Canggih

Pelayanan Khusus hanya diberikan pada Peserta yang memiliki plan Diamond & Ruby sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Plan lain dapat dilakukan dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** sepanjang ditentukan dalam Polis Badan Usaha Peserta BRILIFE.

Pelayanan Khusus yang dilakukan bagi Peserta yang memiliki plan Shappire & Emerald atas persetujuan Peserta BRILife maka **PIHAK PERTAMA** hanya menjamin akomodasi, pelayanan, obat *pra* dan *post* tindakan/operasi.

Pelayanan Khusus meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Tindakan kasus jantung dan paru:
 - 1) Operasi jantung dan paru, ketentuan jumlah pemasangan stent/ring dan jenisnya mengacu pada indikasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**
 - 2) Kateterisasi dan dilatasi pembuluh darah perifer jantung
 - 3) Pemasangan alat Pacu jantung
 - 4) *Thallium scanning*

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- b. Tindakan bedah *thorax* (Pembedahan dengan membuka *Thorax*).
 - c. Tindakan terapi minimal invasif di bidang ortopedi, bidang kebidanan dan kandungan, bidang bedah syaraf dan bidang bedah thorax kardiovaskular.
 - d. Tindakan craniotomi selain kasus kecelakaan.
 - e. Tindakan lasik, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jika terdapat anisometropia, dimana terjadi perbedaan visus/refraksi antara mata kanan dan kiri yang mencapai $-/+7$ dan
 - 2) Jika terdapat kelainan diatas $-/+7$.
 - f. Tindakan *Total Anterior Circulation Infark (TACI) / Trans Arterial Chemoembolization (TACE)*, (chemo langsung ke organ target).
 - g. Tindakan radiotherapi.
 - h. Penunjang diagnostik kedokteran Nuklir.
 - i. Transplantasi organ (Jantung, Ginjal, Mata, Hati, Paru, Sumsum Tulang).
5. Pelayanan Gawat Darurat, terdiri dari:
- a. Konsultasi medis, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter UGD.
 - b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sederhana sampai canggih.
 - c. Tindakan Medis.
 - d. Pemberian obat-obatan sesuai dengan mengutamakan Formularium Nasional (Fornas) dan/ atau Formularium Rumah Sakit yang telah disepakati.
 - e. Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai (BAHP).
 - f. Pemberian Rujukan ke spesialis/subspesialis dan rawat inap.
6. Pelayanan Transfusi Darah
- a. Diberikan atas indikasi medis untuk pelayanan RI, Persalinan.
 - b. Darah diperoleh dari Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) setempat atau UTD di Rumah Sakit, dengan menyerahkan surat permintaan kebutuhan darah dari dokter yang merawat.
 - c. Ketentuan pelayanan darah diatur berdasarkan perjanjian kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) setempat atau dengan Rumah Sakit.
7. Pelayanan kesehatan lain yang tidak diatur dalam Manfaat Pelayanan dalam Perjanjian ini namun mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

C. Kelas/Kamar Perawatan

Dalam hal Peserta harus menjalani rawat inap di **PIHAK KEDUA**, maka hak atas kelas/kamar perawatan ditentukan sebagai berikut:

1. Hak Peserta BRILIFE atas kelas/kamar perawatan adalah sesuai dengan kelas/kamar perawatan yang menjadi haknya sebagaimana tercantum pada Kartu BRILIFE dari Peserta yang bersangkutan.
2. Peserta Manfaat *Top Up* BPJS Kesehatan berhak menempati kelas/kamar perawatan satu tingkat di atas hak kelas/kamar perawatan yang tercantum dalam kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Hlm. 28 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

3. Dalam hal Peserta atas kehendak sendiri dengan alasan apapun mengambil kelas/kamar perawatan di atas kelas/kamar perawatan yang menjadi haknya, maka selisih biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, tetapi akan menjadi tanggung jawab Peserta, sehingga tidak dapat diuangkan dan tidak dapat diKlaim ke **PIHAK PERTAMA**, baik oleh Peserta maupun **PIHAK KEDUA**.
4. Dalam hal kelas/kamar perawatan yang menjadi hak Peserta penuh, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta dirawat di kelas/kamar perawatan yang 1 (satu) tingkat lebih tinggi, untuk maksimal 3 (tiga) hari perawatan, kecuali untuk Peserta yang telah memiliki hak Kelas Perawatan kelas 1.
 - b. Peserta yang memiliki hak Kelas Perawatan kelas 1 dianjurkan untuk memilih Rumah Sakit lain yang telah bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Apabila Hari Rawat maksimal sebagaimana dimaksud huruf a diatas terlewati maka selisih biaya yang timbul atas kondisi tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
5. Dalam hal Peserta mengambil kelas/kamar perawatan di atas haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 (c) Lampiran ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada Peserta mengenai konsekuensi yang timbul dari hal tersebut dan meminta kepada Peserta untuk menandatangani surat pernyataan sanggup membayar selisih biaya yang timbul.

D. Persyaratan administratif dan prosedur mendapatkan Manfaat Pelayanan

1. Persyaratan Administratif
Syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan di Provider Tingkat lanjutan adalah:
 - a. Membawa dan menunjukkan Kartu BRILIFE/ kartu sementara/ *e-Card* pada Aplikasi **PIHAK PERTAMA** dari *handphone* Peserta dengan status aktif pada Aplikasi BRILIFE-Care yang divalidasi dengan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor).
 - b. Menyerahkan surat Rujukan dari Provider Tingkat Pertama kecuali pada Kasus *emergency* atau pemegang kartu dengan Plan Diamond, untuk empat poli spesialis yaitu poli anak, poli mata, poli THT dan poli obgyn.
 - c. Menyerahkan surat perintah rawat inap baik dari dokter yang merawat di Provider Tingkat Pertama atau poli atau unit gawat darurat Rumah Sakit.
2. Prosedur Pelayanan Peserta BRILIFE
 - a. Peserta BRILIFE ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan RJTL dengan memperlihatkan Kartu BRILIFE/ kartu sementara/ *e-Card* pada Aplikasi **PIHAK PERTAMA** dari *handphone* Peserta dengan status aktif pada Aplikasi BRILIFE-Care yang divalidasi dengan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) beserta surat Rujukan dari Provider Tingkat Pertama.
 - b. Petugas Rumah Sakit meneliti kelengkapan dan keabsahan surat Rujukan dan masa berlaku Kartu/ Identitas BRILIFE lain.

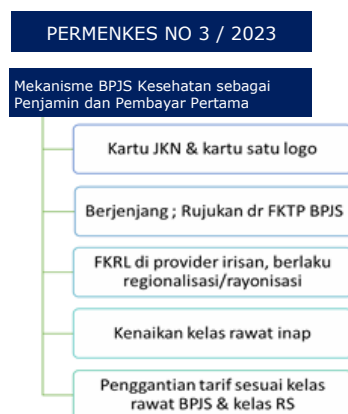
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- Surat Rujukan pada kasus akut berlaku satu bulan untuk satu diagnosa dari tanggal surat Rujukan, sedang pada kasus kronis berlaku tiga bulan dari tanggal surat Rujukan.
 - Rujukan internal berlaku selama-lamanya satu bulan dari tanggal surat Rujukan awal dari Provider Tingkat Pertama.
 - Apabila berkas tidak lengkap, langsung dikembalikan ke Peserta untuk melengkapinya, khusus untuk pelayanan Rawat Inap dapat diberi kesempatan 3 x 24 jam bagi Peserta untuk melengkapi.
- c. Petugas Rumah Sakit selanjutnya meng-*entry* dan menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) tiga rangkap dan diberikan ke Peserta sebagai syarat memperoleh pelayanan dan obat.
- d. Setelah mendapatkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP), Peserta BRILIFE menuju poli spesialis/subspesialis/laboratorium/radiologi dan obat bila memperoleh resep dokter.
- e. Bila Peserta hanya mendapatkan pelayanan di satu poli spesialis/subspesialis, maka Surat Jaminan Pelayanan (SJP) diserahkan di poli spesialis/subspesialis tersebut.
Bila Peserta juga mendapatkan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik atau tindakan, maka Peserta ke unit pelayanan penunjang diagnostik/tindakan dengan membawa:
- 1) Surat permintaan dari dokter
 - 2) Surat Jaminan Pelayanan (SJP) lembar pertama dan bila pelayanan tak berlanjut maka Surat Jaminan Pelayanan (SJP) lembar pertama diserahkan pada poli spesialis/subspesialis.
- g. Bila Peserta mendapat pelayanan di poli spesialis lain (Rujukan *intern*), poli spesialis pertama memberikan "surat Rujukan/konsul *intern*". Di poli spesialis tempat penerima surat Rujukan intern, Peserta menyerahkan surat Rujukan intern dan Surat Jaminan Pelayanan (SJP).
- h. Khusus bagi Peserta yang mendapatkan pelayanan khusus, maka Peserta wajib membawa surat perintah memperoleh Pelayanan Khusus dari **PIHAK PERTAMA**, dan petugas **PIHAK KEDUA** wajib memintakan persetujuan dari Petugas/Karyawan **PIHAK PERTAMA**. Setelah mendapatkan pelayanan khusus, Peserta menyerahkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) kepada **PIHAK KEDUA**.
- i. Bila Peserta mendapat resep, selanjutnya resep tersebut dibawa ke IFRS/Aptek yang bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**, diserahkan bersama dengan Surat Jaminan Pelayanan (SJP).
- j. Bila Peserta BRILIFE diberikan surat perintah rawat inap dari dokter yang merawat maka petugas Rumah Sakit menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Rawat inap dan menyimpan Kartu BRILIFE. Setelah pulang Peserta diarahkan untuk melapor ke admission Rawat Inap untuk mengambil Kartu BRILIFE dan petugas RS menginput tanggal pulang dan tanggal kontrol bila ada pada Aplikasi BRILIFE-Care.
- k. Peserta yang membawa surat perintah kontrol kembali, maka petugas Rumah Sakit menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) yang baru.

Hlm. 30 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

3. Prosedur Pelayanan Manfaat *Top Up* BPJS Kesehatan
- Secara umum, prosedur pelayanan Manfaat *Top Up* BPJS Kesehatan dengan mekanisme yang berlaku, sebagai berikut:



Adapun prosedur pelayanan Peserta Manfaat *Top Up* BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

Mekanisme pelayanan sesuai ketentuan dan prosedur BPJS Kesehatan sebagai penjamin dan pembayar pertama.

- a. Prosedur Pelayanan Rawat Jalan (tidak berlaku bagi produk I-Flexy Smart):
 - 1) **PIHAK KEDUA** menerbitkan Surat Eligibilitas Pelayanan (SEP) Rawat jalan atas Peserta Manfaat *Top Up* BPJS Kesehatan yang datang ke Rumah Sakit dengan membawa Kartu BRILIFE dan Kartu BPJS Kesehatan serta Rujukan Pcare.
 - 2) Khusus untuk Manfaat *Top Up* maka petugas Rumah Sakit juga menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) sebagai syarat memperoleh pelayanan sesuai ketentuan.
 - 3) SEP dan/atau SJP selanjutnya dibawa Peserta ke Poli atau penunjang diagnostik atau ke apotek/IFRS untuk memperoleh pelayanan.
- b. Prosedur pelayanan Rawat Inap (RI)
 - 1) Karena indikasi medis Peserta perlu mendapatkan pelayanan Rawat Inap Lanjutan maka dokter menerbitkan Surat Perintah Rawat Inap.
 - 2) Peserta membawa Surat Perintah Rawat Inap, Kartu BPJS Kesehatan dan Kartu Peserta BRI Life, surat Rujukan dari Rumah Sakit.
 - 3) Petugas Rumah Sakit menerbitkan Surat Eligibilitas Pelayanan (SEP) Rawat Inap sesuai hak kelas Peserta yang tercantum dalam Kartu BPJS Kesehatan Peserta sebagai syarat penagihan Klaim Rawat Inap ke BPJS Kesehatan.
 - 4) Petugas Rumah Sakit juga menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Rawat Inap sebagai syarat Peserta memperoleh pelayanan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Rawat Inap sesuai hak kelas di BRILIFE dan penagihan selisih hak kelas ke **PIHAK PERTAMA**.

4. Prosedur Pelayanan *Telemedicine*

Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyediakan pelayanan *Telemedicine*, maka mekanisme pelayanan *Telemedicine* di **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- 1) Peserta BRILIFE akan menghubungi ruang *chat/call/video call* pada nomor/aplikasi yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pendaftaran.
- 2) **PIHAK KEDUA** meneliti kelengkapan dan keabsahan Peserta dengan meminta Peserta mengirimkan foto Kartu Peserta BRILIFE dan kartu identitas (KTP/SIM) untuk dilakukan validasi. Apabila berkas tidak lengkap, langsung diinformasikan ke Peserta untuk melengkapinya.
- 3) **PIHAK KEDUA** melakukan entri dan terbit SJP *Telemedicine* secara *realtime* di Aplikasi BRILIFE-Care.
- 4) **PIHAK KEDUA** selanjutnya meng-*entry*, mencetak, memberikan pernyataan dan jaminan keaslian atas Surat Jaminan Pelayanan (SJP) dengan syarat dan mekanisme setiap *entry* harus menggunakan Aplikasi BRILIFE-Care dengan mengakses melalui <https://healthcare.brilife.co.id/provider/> dan memilih SJP *Telemedicine* serta login dengan username dan password yang sudah diberikan.
- 5) **PIHAK KEDUA** selanjutnya menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP), kemudian ditandatangani oleh Petugas dan tidak mensyaratkan tanda tangan Peserta BRILIFE.
- 6) Peserta yang telah dinyatakan valid di Aplikasi BRILIFE-Care mendapatkan pelayanan *Telemedicine* yang ditindaklanjuti oleh **PIHAK KEDUA** dengan memilih dokter yang *available* dan Peserta akan dihubungi oleh dokter **PIHAK KEDUA**.
- 7) **PIHAK KEDUA** akan merespon chat Peserta paling lambat dalam 3 menit dan dokter **PIHAK KEDUA** akan menghubungi Peserta paling lambat dalam 3 menit sejak mendapat konfirmasi dari **PIHAK KEDUA**.
- 8) Setelah pelayanan *Telemedicine* selesai, dokter **PIHAK KEDUA** yang memberikan pelayanan kesehatan dan obat menuliskan diagnosa pada bukti kunjungan.

E. Tindak Lanjut

1. Setelah mendapatkan pelayanan RJTL, beberapa kemungkinan sebagai tindak lanjut bagi Peserta BRILIFE, adalah:
 - a. Pelayanan RJTL selesai diberikan Rujukan balik.
 - b. Peserta pulang, tetapi disuruh kontrol kembali.
 - c. Peserta BRILIFE dirawat.
 - d. Peserta BRILIFE dirujuk.
2. Rujukan Intern

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Bila diperlukan konsul kebagian/Poliklinik spesialis lain, maka Peserta diberikan surat Rujukan/konsul intern di dalam lingkungan Rumah Sakit tersebut. Selanjutnya perhatikan alur pelayanan diatas.

3. Rujukan *Ekstern* bila Peserta dirujuk keluar dari lingkungan Rumah Sakit tersebut, maka Peserta diberikan surat Rujukan/konsul ekstern dari Rumah Sakit pengirim.

F. Pelayanan yang Tidak Ditanggung PIHAK PERTAMA (disesuaikan dengan ketentuan dalam polis Peserta BRILIFE)

1. Tidak sesuai ketentuan, prosedur dan indikasi medis.
2. Pelayanan/pengobatan terhadap gangguan mental dan perilaku (*schizophrenia, schizotypal, delusional disorders*) dalam kategori F20 – F29 ICD-10.
3. Penyakit yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri (upaya bunuh diri, olah raga berbahaya, penyalahgunaan narkoba/zat adiktif lain)
4. Pelayanan bersifat kosmetik dan estetik, termasuk perawatan keloid yang tidak mengganggu fungsi.
5. Imunisasi diluar imunisasi dasar.
6. Khitanan tanpa indikasi medis.
7. Pelayanan yang belum diakui secara sah oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (masih dalam uji coba).
8. Pelayanan program dalam upaya memperoleh keturunan.
9. Alat bantu kesehatan antara lain dan tidak terbatas pada: kursi roda, tongkat penyangga, korset, kantong es batu/air hangat, pispot, kasur decubitus, *decker, underpad*.
10. Biaya transportasi/*ambulance, fotocopy, telepon*.
11. Biaya administrasi lain yang tidak terkait dengan pengobatan (misalnya. administrasi pengurusan surat-surat keterangan kelahiran, resume medis, visum dll)
12. Memulihkan kesehatan selain di Rumah Sakit (Homecare, Sanatorium dan sejenisnya).
13. AIDS dan ARC (*Aids Relative Complex*), HIV positive, termasuk dan tidak terbatas pada pemeriksaan HIV dalam darah.
14. Kelainan bawaan/congenital dan hereditas, misalnya: hernia pada usia sampai dengan 8 tahun, VSD, ASD, debil, embicil, mongoloid, cretinism, thalassemia, haemophilli, autism, dan lain-lain.
15. Kelainan Tumbuh Kembang.
16. *General Check Up, screening* kesehatan dan tes kesehatan yang tidak berhubungan dengan pengobatan.
17. Pemeriksaan HBV-DNA secara langsung tanpa didahului pemeriksaan HbsAg.
18. *Screening* ulang darah oleh Rumah Sakit
19. Pembersihan karang gigi (*scalling*), upaya-upaya/tindakan perataan letak gigi (*orthodontie*), pemutihan gigi (*bleaching*), mahkota selubung dan mahkota jembatan.
20. Dialisa (*Peritoneal dialisa* dan *Haemodialisa*)

Hlm. 33 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

21. Pembuatan *Visum et repertum*.
22. Vitamin, multivitamin, obat-obatan herbal dan suplemen diluar Fornas.
23. Penyakit Menular Seksual dalam kategori A50 – A64 ICD-10.
24. Pengobatan akibat tindakan percobaan melanggar hukum, kriminal, melawan penahanan yang sah, Peserta BRILIFE diserang akibat tindakan provokasi yang dilakukannya.
25. Pelayanan khusus bagi plan Silver, Blue, Alba kecuali diatur dalam Polis Badan usaha atau **PARA PIHAK** sepakat memberlakukan manfaat ini sesuai dengan tarif yang disepakati.

Catatan: Bila ada pemeriksaan/tindakan yang tidak ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, maka dokter yang bersangkutan wajib menginformasikan kepada Peserta BRI Life.

G. Tarif Pelayanan Kesehatan

1. Tarif pelayanan kesehatan Produk BRILIFE Managed Care
Tarif pelayanan kesehatan bagi Produk BRILIFE Managed Care adalah sesuai dengan (Isi dengan: SK Direksi/Kepala RS/SK Bupati No... tahun.... atau tarif RS tahun dengan diskon %).
2. Tarif pelayanan kesehatan Produk BRILIFE Managed Care dengan Manfaat *Top Up* BPJS Kesehatan
 - a. Tarif pelayanan pada angka 1 huruf F Lampiran ini hanya berlaku untuk Manfaat Top Up Rawat Jalan Lanjutan dan.
 - b. Pada pelayanan Rawat Inap bila Peserta menempati kelas rawat satu tingkat dari hak BPJS Kesehatan (tidak termasuk bila karena kelas sesuai hak penuh) maka tarif yang ditagihkan adalah tarif sesuai angka 1 huruf F Lampiran ini dikurangi tarif INA-CBG kelas sesuai hak BPJS Kesehatan.
 - c. Apabila ternyata tarif kesepakatan BRILIFE pada angka 1 huruf F Lampiran ini lebih kecil dari Biaya yang ditagihkan ke BPJS Kesehatan (Hasil Luaran Grouper INA-CBG) dengan mekanisme BPJS Kesehatan sebagai penjamin dan pembayaran pertama maka **PIHAK KEDUA** tidak menagihkan biaya apapun ke **PIHAK PERTAMA** / maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan *Administration Fee* sebesar% dari tagihan **PIHAK KEDUA** ke BPJS Kesehatan. (Pilih sesuai yang disepakati)
3. Tarif pelayanan pada angka 1 huruf F Lampiran I ini akan diinput sebagai Jenis Pelayanan ke aplikasi **PIHAK PERTAMA** oleh *Provider Relation Officer*.

E. Biaya Pelayanan Obat dan Penyediaan Ketersediaan Formularium Nasional (Fornas) dan di PIHAK KEDUA

1. Biaya Obat
 - a. Biaya pelayanan obat Formularium Nasional (Fornas) dan/atau Formularium Rumah Sakit bagi Peserta BRILIFE sesuai dengan ketentuan dalam buku

Hlm. 34 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Formularium Nasional (Fornas) dan/ atau Formularium Rumah Sakit yang berlaku.

- b. Harga obat Formularium RS yang disepakati adalah sebesar: **(Jika menggunakan Formularium RS, pilih salah satu)**

Pilihan 1: Harga Netto Apotek (HNA)+PPN 10 % x Faktor Pelayanan Fornas

Pilihan 2: Harga Netto Apotek (HNA)+PPN 10 % x Margin (maksimal 1,2 dari harga obat yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**)

Commented [JHI11]: Sesuaikan dengan kesepakatan dengan RS

Harga satuan	Faktor Pelayanan Maksimal
≤ Rp 50.000,-	0.20
> Rp 50.000,- sampai dengan ≤ Rp 250.000,-	0.15
> Rp 250.000,- sampai dengan ≤ Rp 500.000,-	0.10
> Rp 500.000,- sampai dengan ≤ Rp 1.000.000,-	0.05
> Rp 1.000.000,-	0.02

- c. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menarik biaya apapun terhadap Peserta sepanjang pelayanan obat bagi Peserta yang diberikan masih masuk dalam ruang lingkup.

2. Prosedur Pelayanan

a. Alur Pelayanan Obat ke Peserta

- 1) Obat yang diresepkan kepada Peserta BRILIFE dan Peserta Manfaat *Top Up* BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:
 - a) Rawat Jalan mengacu kepada Formularium Nasional (Fornas) dan/ atau Formularium Rumah Sakit.
 - b) Rawat Inap mengacu kepada Formularium Nasional (Fornas) dan/ atau Formularium Rumah Sakit yang disepakati.
- 2) Peresepan mengutamakan Obat Formularium Nasional (Fornas) dan/ atau Formularium Rumah Sakit, IFRS menerima resep dari Peserta yang berasal dari Provider BRILIFE, dengan menunjukkan Kartu BRILIFE asli yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**, SJP-RJL dan lembar resep asli dari dokter yang sudah ditandatangani dokter yang memeriksa/merawat.
- 3) Bila obat yang diresepkan oleh Dokter BRILIFE tidak terdapat dalam Formularium Nasional (Fornas) dan/atau Formularium Rumah Sakit maka IFRS dapat mengganti obat tersebut dengan obat yang kelas terapi, isi dan dosisnya sama dengan yang terdapat dalam Formularium Nasional (Fornas) dan/atau Formularium Rumah Sakit dengan terlebih dahulu menyampaikan hal tersebut kepada Dokter penulis resep baik secara langsung maupun via telepon.
- 4) Bila obat Formularium Nasional (Fornas) dan Formularium Rumah Sakit yang diresepkan oleh Dokter BRILIFE tidak tersedia di IFRS, maka IFRS dapat mengganti obat tersebut dengan menggunakan obat Formularium Nasional (Fornas) dan/atau Formularium Rumah Sakit merek dagang

Hlm. 35 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

lainnya atau Formularium Rumah Sakit dengan harga Formularium Nasional (Fornas) dan/ atau Formularium Rumah Sakit atau kesempatan.
(pilih salah satu)

- b. Prosedur penyerahan obat oleh IFRS sebagai berikut:
 - 1) IFRS wajib menjelaskan jumlah / jenis dan harga obat yang diberikan kepada Peserta BRILIFE.
 - 2) Peserta menandatangani tanda terima obat pada resep tersebut, setelah obat diserahkan.
- c. Jumlah Obat Yang Diberikan:
Obat RJL diberikan sesuai kebutuhan medis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Obat simptomatik diberikan maksimum 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari.
 - 2) Obat kronis dapat diberikan maksimum untuk keperluan 30 (tiga puluh) hari pada kasus dan keadaan tertentu.
 - 3) Antibiotika diberikan yang diberikan mengacu pada ketentuan dalam Formularium Nasional (Fornas) dan/atau Formularium Rumah Sakit.
 - 4) Obat Khusus dan Obat Kanker yang diberikan mengacu pada ketentuan dalam Formularium Nasional (Fornas) dan/atau Formularium Rumah Sakit.

F. Tata Cara Pengajuan Tagihan oleh PIHAK KEDUA dan Tata Cara Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA

1. Ketentuan Umum
 - a. Pengajuan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan Peserta BRILIFE oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan secara kolektif.
 - b. Pengajuan tagihan (dengan berkas fisik atau Berkas Elektronik) oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan secara teratur setiap bulannya, yaitu pelayanan Produk Managed Care selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) di Hari Kerja bulan berikutnya.
 - c. Tagihan Klaim baik pada kasus Rawat Jalan Tingkat Lanjutan ataupun kasus Rawat Inap Tingkat Lanjutan, sebagai berikut:
 - 1) Tagihan Klaim pelayanan Managed Care
Tagihan/*invoice* atas biaya Pelayanan Peserta oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan secara kolektif melalui aplikasi yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan berkas Klaim pelayanan (dengan berkas fisik atau Berkas Elektronik), yang dilampirkan pada setiap nomor SJP per Peserta, berkas pengajuan Klaim pelayanan sebagai berikut:
 - a) Formulir Pengajuan Klaim (FPK) rangkap 3 (tiga).
 - b) Lampiran rekapitulasi pelayanan atau perincian biaya pelayanan luaran aplikasi atau manual.
 - c) Surat Rujukan/keterangan gawat darurat.

Hlm. 36 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- d) Surat Jaminan Pelayanan (SJP) RJTP/RI.
 - e) Bukti-bukti pendukung seperti bukti pemeriksaan, bukti permintaan dan hasil penunjang diagnostik, bukti permintaan dan hasil tindakan medik, bukti diagnosis yang menyebutkan nama dokternya atau bukti resume medis, bukti laporan operasi (bila diperlukan), bukti surat keterangan gawat darurat/emergency bila Klaim Kasus Gawat Darurat (*emergency*). Bukti-bukti tersebut ditandatangani oleh petugas yang bertanggung jawab dalam setiap kegiatan pelayanan.
- 2) Tagihan Klaim obat Managed Care
- Tagihan/invoice atas biaya Pelayanan Obat Peserta oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan secara kolektif melalui aplikasi online yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan berkas Klaim obat (dengan berkas fisik atau Berkas Elektronik), yang dilampirkan pada setiap nomor SJP per Peserta, pengajuan berkas Klaim obat sebagai berikut:
- a) Formulir Pengajuan Klaim (FPK) rangkap 3 (tiga).
 - b) Asli Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Rawat Jalan Lanjutan/Rawat Inap Lanjutan.
 - c) Salinan Resep atau billing pelayanan.
 - d) Rekapitulasi pelayanan obat luaran aplikasi atau manual.
- d. Pengajuan tagihan pelayanan Managed Care oleh **PIHAK KEDUA** sedapat mungkin diajukan bersama tagihan Klaim Obat dalam satu waktu.
 - e. Pengajuan tagihan Managed Care oleh **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** wajib diajukan secara elektronik melalui aplikasi online yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** disertai dokumen administrasi Klaim (dengan berkas fisik atau Berkas Elektronik) sesuai yang tercantum pada angka I huruf C lampiran V ini. Dalam hal SIM RS **PIHAK KEDUA** sudah bridging dengan aplikasi **PIHAK PERTAMA** maka pengajuan tagihan cukup diinput dalam aplikasi SIM RS **PIHAK KEDUA**.
 - f. Dalam hal berkas tagihan Managed Care yang disampaikan tidak atau belum memenuhi persyaratan atau belum lengkap, maka berkas tagihan yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk diperbaiki atau dilengkapi. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** wajib segera mengirimkan kembali berkas tagihan yang telah diperbaiki atau dilengkapi tersebut ke **PIHAK PERTAMA** dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak berkas tersebut dikembalikan dan selama-lamanya 3 (tiga) bulan hari dari tanggal pelayanan dilakukan atau tanggal pulang bila Klaim Rawat Inap.
 - g. Masa kadaluwarsa Klaim Managed Care adalah bila melebihi 3 (tiga) bulan dari tanggal pelayanan dilakukan atau tanggal pulang bila Klaim Rawat Inap.
 - h. Dalam hal Jangka Waktu Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK**, maka pengajuan tagihan Managed Care yang dapat disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** wajib diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Perjanjian ini.
 - i. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan Verifikasi atau pemeriksaan terhadap tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**. Dalam hal hasil Verifikasi

Commented [JOA12]: Perlukah ?

Hlm. 37 dari 40

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

terhadap tagihan tersebut **PIHAK PERTAMA** menemukan adanya kekeliruan atau penyimpangan maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menolak pembayaran tagihan atau meminta **PIHAK KEDUA** untuk memperbaiki tagihannya dan menyampaikan tagihan yang telah diperbaiki kepada **PIHAK PERTAMA**.

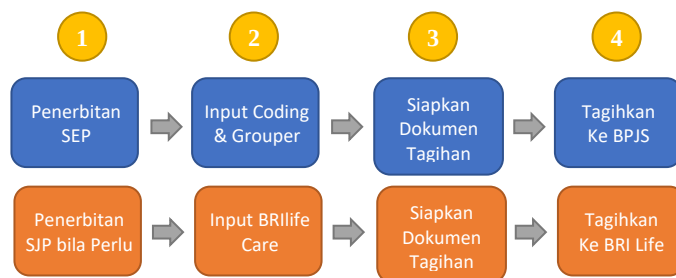
- j. Apabila **PIHAK PERTAMA** telah melakukan pembayaran dan di kemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran tagihan kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** atau dikompensasikan di pembayaran bulan berikutnya begitupula sebaliknya.
 - k. Untuk penyampaian dokumen secara digital maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keaslian Berkas Elektronik, dan dapat memberikan berkas asli kepada **PIHAK PERTAMA** apabila dibutuhkan.
2. Tata cara pengajuan Klaim Managed Care bagi Provider Irisan BPJS Kesehatan
- a. Pengajuan Klaim Manfaat Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan
 - 1) Klaim yang dapat diajukan ke **PIHAK PERTAMA** adalah Klaim sesuai hak Peserta BRILIFE berdasarkan plan dan manfaat asuransi yang dimilikinya dan prosedur BRILIFE yaitu:
 - a) Klaim atas Manfaat Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan Peserta BRILIFE, dan atau
 - b) Klaim atas Manfaat Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan atas pelayanan Manfaat Top Up yang diperoleh Peserta Manfaat *Top Up* BPJS Kesehatan dengan Kartu satu logo, dan atau
 - c) Klaim atas Manfaat Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan Peserta Manfaat *Top Up* BPJS Kesehatan dengan Kartu dua logo.
 - 2) Pengajuan Klaim dilakukan langsung oleh **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** sesuai tarif pelayanan yang tercantum dalam lampiran IV Perjanjian ini. Syarat dan dokumen Klaim mengacu pada point I. C lampiran ini.
 - b. Pengajuan Klaim Manfaat Pelayanan Rawat Inap Lanjutan
 - 1) Klaim Manfaat Pelayanan Rawat Inap dengan Manfaat *Top Up* BPJS Kesehatan yaitu Klaim Rawat Inap Peserta yang dapat diajukan dengan mekanisme BPJS Kesehatan sebagai penjamin dan pembayar pertama.
 - 2) Pengajuan tagihan oleh **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** diajukan secara elektronik dalam dua register terpisah disertai dokumen administrasi Klaim Manfaat *Top Up* BPJS Kesehatan sesuai lampiran ini.
 - 3) Pengajuan Klaim Rawat Inap Manfaat *Top Up* BPJS Kesehatan dengan mekanisme BPJS Kesehatan sebagai penjamin dan pembayar pertama, **PIHAK KEDUA** memisahkan tagihan Rawat Inap (*Split Billing*) sesuai hak dan prosedur BPJS Kesehatan ke BPJS Kesehatan, dan sesuai hak dan prosedur **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Mekanisme penagihan BPJS Kesehatan sebagai penjamin dan pembayar pertama dikenakan pada tagihan Klaim Manfaat Pelayanan Rawat Inap Peserta dengan Kartu BRILIFE Satu Logo yang memenuhi prosedur pelayanan BPJS Kesehatan.

Langkah-langkah penagihan sebagai berikut:

- (1) Klaim Rawat Inap sesuai hak kelas rawat Peserta yang tercantum di kartu BPJS Kesehatan dan sesuai hak dan ketentuan BPJS Kesehatan diajukan langsung oleh **PIHAK KEDUA** ke BPJS Kesehatan secara elektronik melalui aplikasi INA-CBG. Syarat pengajuan dan dokumen Klaim mengacu pada ketentuan BPJS Kesehatan.
- (2) Dalam hal Peserta menempati kelas rawat satu tingkat lebih tinggi dari hak kelas rawat yang tercantum dalam Kartu BPJS Kesehatan Peserta maka selisih biaya Klaim yang timbul diajukan oleh **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** melalui aplikasi online **PIHAK PERTAMA**. Syarat dan dokumen Klaim Manfaat Pelayanan Rawat Inap mengacu kepada point I Ketentuan Umum lampiran ini.
- (3) Alur skema penagihan mekanisme BPJS Kesehatan sebagai penjamin dan pembayar pertama sebagaimana pada bagan berikut:



3. Tata Cara Pembayaran

- a. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal **PIHAK PERTAMA** telah menerima secara lengkap tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dan proses Verifikasi selesai dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Tagihan Produk BRILIFE Managed Care yang diajukan lebih dari 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya Bulan Pelayanan dan/ atau berakhirnya Perjanjian ini (tanpa ada kesepakatan **PARA PIHAK** untuk memperpanjang Perjanjian ini, berhak untuk ditolak atau tidak membayarkan tagihan pembayarannya oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab untuk membayar tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, yang timbul oleh karena **PIHAK KEDUA** memberikan fasilitas dan/ atau pelayanan kesehatan kepada Peserta

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

BRILIFE yang tidak termasuk hak Peserta BRILIFE sesuai dengan plan dan manfaat asuransi yang dimilikinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA